

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

CUBI-18 · CUESTIONARIO DE URGENCIA, BÚSQUEDA DE SENSACIONES E IMPULSIVIDAD

Evaluación psicométrica multidimensional breve de facetas impulsivas y disregulación emocional

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial	Cuestionario de Urgencia, Búsqueda de Sensaciones e Impulsividad (CUBI-18)
Autores Originales	Martín Squillace Louhau y Juan Carlos Picón-Janeiro (2019)
Procedencia y Validación	Universidad de Buenos Aires / CONICET (Argentina). Diseñado originalmente en idioma español.
Tipo de Instrumento	Autoinforme psicométrico dimensional breve
Población Diana	Población general y clínica de adolescentes y adultos (16 a 65 años)
Tiempo de Aplicación	4 a 7 minutos (18 ítems autoadministrados)
Formato de Respuesta	Escala Likert de 5 opciones: 1 (Totalmente en desacuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo)
Finalidad Clínica	Detección y estratificación de perfiles de impulsividad motora, atencional y afectiva en patología adictiva, trastornos de la personalidad y conductas de riesgo

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

El CUBI-18 fue formulado para resolver la necesidad de un instrumento parsimonioso en idioma español que capture los tres componentes cardinales del constructo de impulsividad operacionalizados en los modelos contemporáneos de neurociencia afectiva y en el modelo UPPS de Whiteside y Lynam. A diferencia de las conceptualizaciones unidimensionales clásicas, la impulsividad se entiende como una entidad transdiagnóstica heterogénea caracterizada por: a) la tendencia a ceder a impulsos urgentes ante estados de activación afectiva intensa (urgencia emocional compulsiva), b) la motivación de aproximación hacia estímulos novedosos, excitantes o potencialmente peligrosos (búsqueda de sensaciones), y c) la inhabilidad para demorar la gratificación o reflexionar en las consecuencias a largo plazo de la conducta antes de ejecutarla (imprevisión o falta de premeditación).

El modelo subyacente del CUBI-18 posee alta validez ecológica al discriminar con precisión trayectorias diferenciales de riesgo conductual: la faceta de urgencia se correlaciona selectivamente con disregulación afectiva, autolesiones no suicidas, atracones y episodios explosivos intermitentes; la búsqueda de sensaciones covaría con inicio temprano de abuso recreativo de tóxicos y conductas arriesgadas al volante; y la imprevisión refleja disfunción ejecutiva en memoria de trabajo y control inhibitorio de corte prefrontal.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Subescala / Factor	Nº Ítems	Ítems Constituyentes	Significado Clínico / Operacional
Urgencia Compulsiva	6 ítems	1, 4, 7, 10, 13, 16	Tendencia a actuar de forma precipitada o desadaptativa bajo emociones de displacer o rabia intensa.
Búsqueda de Sensaciones	6 ítems	2, 5, 8, 11, 14, 17	Apetencia marcada por actividades intensas, novedosas y con riesgo físico o interpersonal percibido.
Impulsividad por Imprevisión	6 ítems	3, 6, 9, 12, 15, 18	Falta de planeamiento reflexivo, incapacidad de previsión de desenlaces negativos antes de actuar.
Puntuación Total CUBI	18 ítems	Suma global de ítems (1 a 18)	Índice global de reactividad impulsiva general y labilidad inhibitoria transdiagnóstica.

Nota operativa: Todos los ítems se puntúan de forma directa (1 a 5). La puntuación en cada dimensión oscila entre 6 y 30 puntos, y la puntuación global compuesta varía de 18 a 90 puntos.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · CUBI-18

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

Consistencia Interna	Excelente consistencia global (Alfa de Cronbach = 0.84, Omega de McDonald = 0.86). Subescalas: Urgencia (alfa = 0.81), Búsqueda de Sensaciones (alfa = 0.79), Imprevisión (alfa = 0.77).
Estructura Factorial	Análisis factorial confirmatorio (AFC) ratificó con solidez la estructura de 3 factores oblicuos correlacionados (CFI = 0.942, TLI = 0.931, RMSEA = 0.051, SRMR = 0.048).
Validez Convergente	Correlación positiva robusta con la escala BIS-11 de Barratt ($r = 0.71$), UPPS-P ($r = 0.76$) y facetas de Búsqueda de Novedad del TCI-R de Cloninger ($r = 0.64$).
Validez Discriminante	Diferenciación estadísticamente significativa ($p < 0.001$, d de Cohen = 1.12) entre población general no consultante y cohortes clínicas con Trastorno por Uso de Sustancias y TLP.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

- Verificación de Completitud:** Verificar que los 18 reactivos hayan sido cumplimentados. Si faltan más de 2 ítems en el protocolo, la prueba se invalida formalmente.
- Asignación Directa de Puntos:** Cada ítem se califica según el valor seleccionado: Totalmente en desacuerdo = 1, En desacuerdo = 2, Neutral = 3, De acuerdo = 4, Totalmente de acuerdo = 5. No contiene ítems invertidos.
- Cómputo Factorial:**
 - Urgencia Compulsiva:** Suma de los ítems 1, 4, 7, 10, 13 y 16 (Rango: 6 a 30).
 - Búsqueda de Sensaciones:** Suma de los ítems 2, 5, 8, 11, 14 y 17 (Rango: 6 a 30).
 - Impulsividad por Imprevisión:** Suma de los ítems 3, 6, 9, 12, 15 y 18 (Rango: 6 a 30).
- Puntuación Total:** Suma de los tres factores (Rango: 18 a 90). Puntuaciones brutas pueden transformarse a percentiles normativos tipificados.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Nivel de Severidad	CUBI Total	Percentil Aprox.	Interpretación Psicopatológica y Funcional
Baja Impulsividad	18 a 34 puntos	< P25	Capacidad adecuada de autorregulación emocional, reflexión y baja búsqueda de riesgo.
Impulsividad Normal	35 a 52 puntos	P25 a P74	Perfil adaptativo normativo sin compromiso significativo del control inhibitorio.
Impulsividad Elevada	53 a 67 puntos	P75 a P89	Falta evidente de control en al menos un dominio. Mayor vulnerabilidad a conductas lesivas.
Impulsividad Muy Severa	68 a 90 puntos	$\geq$ P90	Compromiso grave del juicio conductual, severa desregulación emocional y riesgo conductual activo.

CRITERIO CLÍNICO DE ELEVACIÓN FACTORIAL DISOCIADA: Una puntuación en cualquiera de los tres factores individuales superior a 22 puntos ($\geq$ P85) debe ser interpretada como un foco clínico de atención primaria, independientemente de que el CUBI Total se encuentre en rango moderado. El factor Urgencia Compulsiva elevado (> 22) requiere evaluación inmediata de riesgo autolítico y descontrol de impulsos.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · CUBI-18

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Aplicación y Verificación: Administrar autoinforme y obtener subtotales de Urgencia, Búsqueda de Sensaciones e Imprevisión.

Paso 2: Triaje Dimensional:

- Si **CUBI Total < 53** y **factores < 20**: Conducta normativa. Monitoreo regular sin necesidad de intervención focalizada en control de impulsos.
- Si **CUBI Total ≥ 53** o **Factor Urgencia ≥ 22**: Priorizar entrenamiento en habilidades de regulación emocional y tolerancia al malestar (Terapia Dialéctica Conductual - DBT, técnica STOP, plan de seguridad para momentos de crisis).
- Si **Factor Imprevisión ≥ 22**: Focalizar en reestructuración de la planificación ejecutiva, demoras forzadas antes de la acción y entrenamiento metacognitivo.
- Si **Factor Búsqueda de Sensaciones ≥ 22**: Canalización de la búsqueda de activación hacia conductas estructuradas y prosociales de bajo riesgo físico.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

Identificación: Mujer de 23 años, estudiante universitaria, derivada por su psiquiatra tratante tras consultar en urgencias por cortes superficiales en antebrazos desencadenados por una ruptura de pareja y gastos impulsivos desmedidos en compras por internet.

Evaluación Psicométrica Inicial: CUBI-18 Total = 69 puntos (Percentil 92, Impulsividad Muy Severa).

- **Urgencia Compulsiva:** 28 / 30 (P98). Reporta sensación de abrumamiento intolerable y necesidad compulsiva de alivio inmediato.
- **Búsqueda de Sensaciones:** 18 / 30 (P55). Rango promedio, sin historial de deportes extremos ni conductas temerarias habituales.
- **Impulsividad por Imprevisión:** 23 / 30 (P88). Dificultad severa para anticipar las consecuencias financieras o físicas en caliente.

Formulación y Abordaje: El perfil del CUBI-18 descartó que las conductas estuviesen guiadas por búsqueda de novedad o temeridad hedónica, confirmando que el motor causal residía en la urgencia emocional ante el afecto negativo intenso. Se inició terapia dialéctico-conductual enfocada en habilidades de tolerancia al malestar (hielo, respiración acompasada, distracción guiada) y contrato de demoras de 24 horas antes de compras electrónicas. En la reevaluación a los 4 meses, la subescala de Urgencia descendió a 16 puntos (P58), con remisión completa de autolesiones.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTAS CRÍTICAS DE SEGURIDAD

- Puntuaciones extremas en Urgencia Compulsiva (> 25) son el predictor psicométrico más potente de paso al acto suicida y autolesiones no suicidas.
- En caso de elevación brusca y no congruente, descartar de inmediato intoxicación aguda por psicoestimulantes o episodio hipomaniaco en curso.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- **TDAH del adulto:** Predomina una marcada imprevisión y distracción ejecutiva sin que la urgencia esté ligada primariamente a crisis de dolor psíquico.
- **Trastorno Límite de la Personalidad:** Marcada disociación afectiva con disparos extremos en Urgencia ante rechazo interpersonal percibido.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Squillace Louhau, M., & Picón-Janeiro, J. (2019). CUBI-18: Cuestionario de Urgencia, Búsqueda de Sensaciones e Impulsividad. *Interdisciplinaria: Revista de Psicología y Ciencias Afines*, 36(2), 7–22.
- Whiteside, S. P., & Lynam, D. R. (2001). The Five Factor Model and impulsivity: Using a structural model of personality to understand impulsivity. *Personality and Individual Differences*, 30(4), 669–689.
- Cyders, M. A., & Smith, G. T. (2008). Emotion-based dispositions to rash action: Positive and negative urgency. *Psychological Bulletin*, 134(6), 807–828.
- Patton, J. H., Stanford, M. S., & Barratt, E. S. (1995). Factor structure of the Barratt Impulsiveness Scale. *Journal of Clinical Psychology*, 51(6), 768–774.